

肥胖与代谢性疾病 考点总结

来源: 第七章 肥胖与代谢性疾病.pdf, 共4页

一、核心考点概述

本章考点集中在肥胖诊断标准(中西方BMI切点差异)、减重手术适应证与禁忌证、两种核心术式(SG和RYGB)的原理与效果对比、%TWL和%EWL计算公式、T2DM缓解分级, 以及术后并发症(尤其是消化道漏和韦尼克脑病)。

二、重点概念与定义

- **肥胖症 (obesity):** 能量摄入过多或代谢改变引起体内脂肪过多存积, 导致体重过度增长, 是一种慢性进行性代谢性疾病 [P1]
- **体脂率:** 脂肪含量占总体重百分比。男正常10%~20%, 女15%~25%; 男 $\geq 25\%$ 、女 $\geq 30\%$ 为肥胖 [P1]
- **袖状胃切除术 (sleeve gastrectomy, SG):** 切除大弯侧大部分胃, 形成60~80ml袖状胃 [P2]
- **Roux-en-Y胃旁路术 (Roux-en-Y gastric bypass, RYGB):** 建立10~20ml近端胃小囊, 旷置远端胃, 行胃空肠吻合+空肠-空肠侧侧吻合 [P2]
- **韦尼克脑病 (Wernicke encephalopathy):** 维生素B1严重缺乏所致, 表现为眼外肌麻痹、精神异常、共济失调 [P3]
- **修正手术 (revisional surgery):** 初次减重手术后效果不佳/复胖/严重并发症所需再次手术 [P4]

三、关键公式与判据

减重效果评估公式 [P3]

$$\%TWL = (\text{术前体重} - \text{随访体重}) / \text{术前体重} \times 100\%$$

$$\%EWL = (\text{术前体重} - \text{随访体重}) / (\text{术前体重} - \text{理想体重}) \times 100\%$$

其中理想体重指BMI=25kg/m²时对应体重 [P3]

手术成功判据 [P3]

- %EWL>50%: 手术成功
- %EWL 25%~50%: 效果不佳
- %EWL<25%: 无效

四、分类/分型/分期

肥胖症分期 [P1]

分期	特征	占比
代偿期	肥胖，无代谢与肥胖相关疾病	~30%
失代偿期(病态性肥胖)	肥胖+≥1种代谢/相关疾病	~70%
功能衰竭期	肥胖+心肺功能衰竭	—

肥胖症按BMI分度 [P1]

分度	BMI范围 (kg/m²)
轻度(I度)	28~32.49
中度(II度)	32.50~37.49
重度(III度)	37.50~49.99
极度(IV度)	≥50

减重手术方式分类 [P2]

1. 胃减容限制摄入型: SG为代表
2. 小肠吸收不良型: 少用，营养并发症多
3. 混合型: RYGB为代表

T2DM缓解效果分级 [P4]

分级	标准
完全缓解	不用降糖药，血糖指标全部正常
部分缓解	不用降糖药，高于正常但未达糖尿病诊断标准
改善	降糖药种类/剂量明显减少，HbA1c<7.0%

分级	标准
无效	降糖药无明显变化，血糖无明显改善

五、鉴别诊断/对比

中国 vs WHO 肥胖BMI标准 [P1]

标准	超重	肥胖
中国	24.0~27.9	≥ 28.0
WHO	—	≥ 30.0

易错: 中国标准更严格，考试常考查此差异。

SG vs RYGB [P2]

项目	SG	RYGB
胃囊容量	60~80ml	10~20ml
操作	切除大弯侧	胃空肠吻合+空肠侧侧吻合
%EWL(1年)	60%~70%	70%~80%
T2DM缓解率	~65%	80%~85%
机制	限制摄入	限制+吸收不良混合

初次手术 vs 修正手术适应证 [P2, P4]

类型	BMI标准
初次手术	BMI ≥ 32.5 或 BMI 27.5~32.49 + ≥ 2 种代谢疾病内科治疗无效
修正手术	BMI ≥ 32.5 (减重不佳) 或 BMI ≥ 27.5 (代谢病疗效欠佳)

六、易错点与技巧

1. **中国肥胖BMI切点:** ≥ 28 (不是WHO的30!) [P1]
2. **腰围标准:** 男 $\geq 85\text{cm}$ ，女 $\geq 80\text{cm}$ (亚洲腹型肥胖为主) [P1]
3. **手术相对禁忌证不包含年龄:** 儿童青少年和老年人可慎重开展，需多学科评估 [P2]
4. **BMI > 50 高危病人:** 先保守治疗降体重5%以上再择期手术 [P2]
5. **消化道漏好发部位:** 胃空肠吻合口或残胃近端近His角 [P2]

6. **维生素B1缺乏→韦尼克脑病**: 眼外肌麻痹+精神异常+共济失调三联征 [P3]
7. **修正手术与初次手术间隔**: 一般 ≥ 24 个月(严重并发症除外) [P4]
8. **修正手术禁忌**: BMI < 27.5 (除非严重营养不良等并发症) [P4]
9. **%EWL分母**: (术前体重-理想体重) 而非总体重 [P3]
10. **术后饮食流程**: 全流质→半流质→软食→普食 [P3]

七、考点速记

- **肥胖诊断三指标**: BMI + 体脂率 + 腰围 [P1]
- **中国超重**: BMI 24~27.9; **肥胖**: BMI ≥ 28 [P1]
- **体脂率**: 男 $\geq 25\%$, 女 $\geq 30\%$ 为肥胖 [P1]
- **腰围**: 男 $\geq 85\text{cm}$, 女 $\geq 80\text{cm}$ [P1]
- **手术适应证核心**: BMI ≥ 32.5 , 或 $\geq 27.5 + \geq 2$ 种代谢病内科无效 [P2]
- **SG胃囊**: 60~80ml; **RYGB胃囊**: 10~20ml [P2]
- **RYGB %EWL**: 70%~80%; **SG %EWL**: 60%~70% [P2]
- **%EWL $> 50\%$** : 手术成功 [P3]
- **术后终身随访** [P3]
- **消化道漏发生率**: 0~7%, 与血供不足、缝合不严、糖尿病有关 [P2]
- **修正手术三种**: 修复(恢复解剖)、修改(改术式)、修理(原术式修改) [P4]